



Discussões em Equipe

Relembrando o caso de Antônia, as discussões sobre ele são sempre marcadas por múltiplas vozes que aparecem pelas falas de outros usuários, dos enfermeiros do hospital, pela equipe do CAPS III parceiro, pela estagiária, pela família e pelo supervisor institucional. A figura do supervisor é muito importante para uma equipe poder olhar certas dinâmicas que às vezes ficam de fora do campo de visão, pelo simples fato de que a equipe faz parte da cena de uma situação de crise. O supervisor, como uma pessoa que está com um pé dentro e outro fora, possibilita essa reflexão coletiva tão importante ao poder olhar com perspectiva para os problemas da equipe. É preciso, no entanto, que a equipe esteja aberta às múltiplas vozes, seja da família, do usuário ou do supervisor.

Algo que costumamos esquecer, até por não lembrarmos das relações de poder entre equipe e usuários, é a reparação. Não se trata de simplesmente “pedir desculpas”, mas reconhecer o que passou dos limites e mudar o que precisa mudar. Às vezes, explicar com calma por que certas decisões foram tomadas; às vezes, reconhecer que um tom foi inadequado; às vezes, combinar outra forma de entrada na próxima vez.

As crises são oportunidades para as equipes, para a gestão planejar estratégias que tornem aquele lugar melhor. A melhoria em saúde se faz apenas com boas ideias, com ciclos de teste, indicadores simples e revisão periódica. Aplicado à crise, isso pode significar monitorar: tempo até primeiro contato, retorno em 48 horas, presença de plano de crise pactuado, número de acionamentos externos, uso de medidas restritivas, a satisfação do usuário e da equipe. A lógica é a mesma do “como medir para melhorar”: medir para aprender. Isso é qualidade!